

## 15 - 03-La syphilis - Pr. Amal

Toujours dans le cadre des maladies sexuellement transmissibles, le cours d'aujourd'hui concerne la syphilis. La syphilis, c'est une infection sexuellement transmissible. Sur le plan historique, il y a deux hypothèses.

Certains auteurs historiques rapportent cette maladie à la période pharaonique, puisqu'on a découvert des momies avec une atteinte osseuse qui orientent vers la syphilis tertiaire. Et d'autres auteurs historiques rapportent la syphilis à la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Et juste parce qu'il y avait une propagation de la maladie en Europe après le retour des marins qui ont accompagné Christophe Colomb, ça a touché l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, et on parlait du mal napolitain ou mal espagnol.

Et c'était à l'époque des formes qui sont graves, mortelles, en absence de traitement. À la fin de ce cours, l'étudiant doit être capable de diagnostiquer une syphilis primaire. La syphilis primaire, nous avons déjà traité ce chapitre dans le cadre des ulcérations génitales.

Diagnostiquer une syphilis secondaire, diagnostiquer une syphilis tertiaire, diagnostiquer une syphilis latente, définir les réactions sérologiques de la syphilis et interpréter les résultats, planifier un traitement pour la syphilis primaire, secondaire et la syphilis latente et tertiaire. La syphilis est une infection sexuellement transmissible dite au *treponema pallidum*. Elle évolue en trois phases.

La phase primaire où vous avez le chancre, qui apparaît en général trois semaines après le rapport sexuel sur la contamination. Puis, si le malade n'a pas été traité, il peut évoluer vers la syphilis secondaire. C'est la phase où il y a une dissémination chimique de *treponema*.

Donc, 30% des malades qui ont fait le chancre syphilitique ou la syphilis primaire peuvent passer à cette phase secondaire. Bien sûr, c'est les malades qui ne sont pas traités. Une fois traité, la syphilis est guérie au stade primaire.

Puis, il y a la syphilis tertiaire qui peut survenir des années après, jusqu'à 10-20 ans après. La syphilis tertiaire fait la gravité de la maladie puisque il y a le risque d'atteinte neurologique, la neurosyphilis. Il y a le risque d'atteinte cardiaque, ophtalmique, osseuse et cutanée.

Et là, c'est 10% des malades qui ont fait la syphilis primaire. S'ils n'ont pas été traités au stade primaire, au stade de syphilis secondaire, ils risquent de développer la syphilis tertiaire. Mais on a enfin la syphilis latente.

La syphilis latente, ça veut dire que c'est une découverte fortuite d'une sérologie syphilitique positive alors que le malade ne présente aucun signe clinique, cutané ou autre. On classe la syphilis en fonction de la durée d'évolution. Ainsi, on distingue entre la syphilis précoce et la syphilis tardif.

La syphilis précoce, c'est une syphilis qui évolue moins d'un an. Elle regroupe la syphilis primaire, le complexe primaire, c'est-à-dire l'ulcération génitale et la thénopathie, la syphilis secondaire et la syphilis latente précoce. La syphilis latente précoce, on a dit que la syphilis latente, c'est la découverte d'une sérologie syphilitique positive.

Et à ce moment-là, si à l'interrogatoire, on arrive à bien définir la date de la contamination, par exemple, la notion d'un choc qui remonte à une durée moins d'un an, on classe cette syphilis latente dans la phase précoce. Sinon, on va classer cette syphilis latente dans la phase tardif et on parle de la syphilis latente tardif. La syphilis tardif, c'est une syphilis qui évolue plus d'un an et elle regroupe la syphilis tertiaire, la syphilis tertiaire cutanée, la syphilis tertiaire cutanée, la syphilis neurologique, la neurosyphilis cardiovasculaire, ophtalmique, osseuse et la syphilis latente tardif.

Donc là, c'est la courbe qui représente la synétique de la sérologie syphilitique et qui regroupe ces différentes phases qu'on vient de citer. Donc, vous avez la notion de contagion. En général, la syphilis est une maladie sexuellement transmissible par voie directe, par voie sexuelle le plus souvent.

Donc, vous avez le rapport sexuel source de contamination. Après trois semaines, vous avez l'apparition du choc. Et là, on parle de la syphilis primaire.

D'accord, donc c'est l'apparition du choc, puis de l'adénopathie. Oui, donc vous avez la phase secondaire, la syphilis secondaire. C'est une syphilis qui évolue moins de un an.

Et là également, il y a la syphilis latente précoce, c'est-à-dire une découverte d'une sérologie positive. Vous avez la sérologie qui est positive, mais qu'il n'y a pas de signe clinique. Donc tout ça, c'est la phase précoce.

Pourquoi on a fait cette classification? C'est dans un but thérapeutique, parce que le traitement de la syphilis primaire, de la syphilis secondaire, de la syphilis latente précoce, donc c'est un seul schéma thérapeutique. Par contre, dans la syphilis tardif, donc c'est la syphilis qui évolue plus d'un an, ça regroupe la syphilis tertiaire, et ça regroupe la syphilis latente tardif. Et là, le traitement, c'est en fonction de différents types d'atteintes.

On va voir ça par la suite. On va revenir à cette courbe pour l'interprétation des réactions sérologiques. Dans la syphilis précoce, on a la syphilis primaire.

La syphilis primaire, c'est le chancre syphilitique qui apparaît trois semaines au moyen après le rapport sexuel, source de contamination. Donc on a vu ça sur le cours intitulé les ulcérations génitales. C'est une ulcération en général unique.

De 1 à 2 cm de diamètre. Indolore. Le fond, il est propre.

Il est induré, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à rapprocher les verges. Mais il y a donc beaucoup d'atypies sur le plan clinique. On a vu tout ça.

Associé à l'adénopathie. Donc pour l'évolution de la syphilis primaire, si on traite à ce stade, donc la syphilis est guérie, on parle de guérison de la syphilis. Si on ne traite pas, l'évolution, il se fait de la régression spontanée du chancre, parfois sans séquelles, parce que le plus souvent, c'est une érosion superficielle, sans laisser de cicatrices, en quelques semaines.

Mais là, c'est la guérison de l'ulcération et non pas la guérison de la maladie. Donc il y a un risque de passage vers les autres phases. La syphilis secondaire dans 30 % des cas et la syphilis tertiaire dans 10 % des cas.

Il peut passer donc directement à la syphilis tertiaire sans passer par la syphilis secondaire. Donc c'est un grand risque. Il faut traiter les malades au stade de syphilis primaire ou au stade de syphilis secondaire pour éviter les complications majeures, surtout la neurosyphilis.

Donc la syphilis secondaire, en général, débute six semaines après le chancre et sa durée est en règle inférieure à un an. Elle correspond à la phase de dissémination systémique du tréponème et se caractérise par une éruption cutanée polymorphe, d'où le nom de la grande simulateuse. Ça veut dire qu'il peut simuler plusieurs pathologies dermatologiques.

On va voir ça après. En général, on distingue deux phases. Une phase précoce qu'on appelle la roséole, première floraison.

Une phase secondaire ou la deuxième floraison où on a donc la phase du syphilis. Donc ces phases sont recoupées parfois de phases asymptomatiques et peuvent s'associer à des signes généraux ou viscéraux d'intensité variable. Donc la roséole syphilitique ou la phase précoce débute en général sept à dix semaines après le chancre, peut durer de quelques jours jusqu'à un ou deux mois.

Donc les lésions sont des macules, roses pâles, parfois érythémateuses, de cinq à quinze millimètres de diamètre, disséminées sur le tronc et la racine des membres, non confluentes. Il n'y a pas de prurites, il n'y a pas de signes fonctionnels et ces lésions régressent spontanément. De ce fait, cette phase le plus souvent passe inaperçue et c'est difficile, même sur le plan iconographique, c'est difficile de prendre ces images.

Donc là, ça c'est une photo tirée d'un livre sur les IST faits par Professeur Serhaty, un des pionniers de la dermatologie au Maroc. On a la deuxième phase, la deuxième floraison, les syphilides. Elle apparaît en général deux à quatre mois après le chancre et dure de un à six mois.

En gros, la lésion élémentaire, c'est une papule et ces papules sont rouges cuivrées, non plurifocales, indolores, de quelques millimètres de diamètre, non confluentes, disposées de manière symétrique sur le tronc, le nombre et les variables, les membres et les visages, parfois

recouvertes d'une fine squamme ou entourées d'une esquamation circulaire périlésionnelle qui est très évocatrice, on appelle la collette de Viet. Certaines localisations sont très évocatrices et notamment la localisation palmonplantaire et la tendinita. Au niveau des visages, ces lésions prennent un aspect annulaire.

On parle de syphilite élégante de Broch. Donc Broch, c'est un ancien dermatologue qui a décrit ces lésions. Au niveau des plis, ces lésions peuvent prendre un aspect érosif et les syphilites se caractérisent par un polymorphisme clinique important.

Il peut y avoir des syphilites recouvertes de squamme ou de croûte. Il peut y avoir des syphilites avec des ulcérations et des lésions nécrologiques, d'où le nom de la grande simulatrice donnée à la syphilite secondaire. Ça veut dire que c'est une maladie qui peut simuler plusieurs dermatoses, par exemple le lichen de Broch, le psoriasis devant ses papules, le psoriasis devant des papules avec des squammes, les hématochromies, les toxidermies.

C'est pour cela qu'il faut être très vigilant et poser le diagnostic parce qu'on a dit que si on ne traite pas le malade au stade de syphilite secondaire ou au stade de syphilite primaire, il y a le risque de passer vers la syphilite tertiaire avec la complication majeure qui est la neurosyphilite. Voici les syphilites. Ce sont des papules rouges cuivrées, parfois associés à des squammes.

Voici la localisation au niveau du visage avec un aspect annulaire. Les syphilites élégantes de Broch. On dit que la localisation palmoplantaire est très évocatrice.

En général, elle est en siège à cheval, des plis pour la main, entourées de squammes. La squamme qu'on appelle la squamme de Bietz. La localisation palmoplantaire est très évocatrice.

La localisation génitale également est très évocatrice. Ce sont des papules et non pas des végétations vénériennes. C'est le principal diagnostic différentiel.

Dans les syphilites, la lésion élémentaire, ce sont des papules. Dans les végétations vénériennes, ce sont des verrues. La localisation au niveau des muqueuses est possible.

Il peut s'agir des lésions maculopapuleuses arrondies à limites nettes. Ici, on voit cette papule au niveau de la langue. Indolores qui peuvent devenir érosives ou végétantes.

Les lésions au niveau des muqueuses sont très contagieuses parce qu'elles contiennent le *treponema pallidum*. Il faut faire attention à l'examen clinique. Il faut mettre des gants.

La même chose pour l'ulcération génitale dans le cadre du choc syphilitique. Elles contiennent le *treponema pallidum*. Donc ces lésions peuvent durer plusieurs mois.

Au niveau de la langue, elles peuvent donner un aspect de plaque fauchée, c'est-à-dire des parties de langue qui sont dépapillées. Il peut y avoir une atteinte du pharynx, du larynx. Et au niveau de la commissure labiale.

Donc au niveau de la commissure labiale, il faut faire attention. Il y a ce qu'on appelle la fosse perleche. Rappelez-vous, dans la perleche, on a une fissure de la commissure labiale.

Dans la syphilis secondaire, il peut y avoir des papules surmontées d'une fissure. Donc il y a un relief. Et c'est ce qu'on appelle la fosse perleche.

Il peut y avoir également l'atteinte des organes génitaux externes. Donc l'atteinte dépanneur également est possible au cours de la syphilis secondaire. Donc il peut y avoir l'alopecie enclérière, comme le cas chez ce patient.

Donc vous voyez ces zones dépilées au niveau du cuir chevelu. Il peut y avoir une alopecie diffuse, le cas de ce patient. Il peut y avoir des dépilations des sourcils, le cas de ce patient également, avec même une atteinte ici du cuir chevelu.

Il peut y avoir donc une atteinte au niveau des cils, au niveau de la barbe. Il peut y avoir également un périonexis. Les signes généraux traduisent la dissimulation de l'infection.

Ils sont le plus souvent discrets, mais peuvent être sévères. Les œuvres, le plus souvent 38-38,5°C, pourront atteindre 39-39°C. Les céphalées, qui ne sont pas synonymes d'une atteinte neuromélangée, mais souvent secondaire à des micro-abcès périostés, un syndrome mélangé, des poléarthralgies, des douleurs osseuses et parfois une altération de l'état général.

On peut trouver également des poléarthénopathies, une hépatite biologique, donc avec un bilan hépatique on trouve une cétolise. On peut trouver une hépatose pleine oméga-E, des douleurs osseuses, des douleurs articulaires, l'orchéopédédémite, les glomerules onéflites. Il peut y avoir également une atteinte ophtalmique, surtout une uveïde antérieure, mais aussi une uveïde postérieure est possible, une iridocyclite, une chorio-ritinite.

Donc la syphilis latente est asymptomatique, le malade ne présente aucun signe clinique. Il est de découverte force 8, c'est la cirologie qui est positive, donc de découverte force 8 lors d'un temps du sang par exemple. Il faut distinguer entre la syphilis latente précoce évoluant moins d'un an et la syphilis latente tardive évoluant de plus d'un an.

C'est un interrogatoire qu'on peut préciser s'il s'agit d'une syphilis latente précoce ou tardive, si le malade vous rapporte la date exacte de l'apparition du chancre syphilitique, ou bien si le malade a déjà une cirologie syphilitique négative datant de moins d'un an. 25% des syphilis latentes non traitées évoluent vers une syphilis tertiaire. La syphilis tertiaire, c'est une syphilis tardive qui apparaît après un an et plus, donc jusqu'à 10 ans après le chancre syphilitique.

Elle peut donner une atteinte cutanio-muqueuse, une atteinte osseuse, cardiovasculaire et surtout neurologique, donc la neurosyphilis qui fait la gravité de la maladie. Sur le plan histologique, la syphilis tertiaire se caractérise par des lésions de destruction et de sclérose. Ce sont des lésions non contagieuses parce qu'elle ne contient pas de tréponema pallidum.

La syphilis tertiaire cutanée est devenue très rare. Donc les lésions alimentaires, essentiellement, ce sont des gommès. Donc les gommès, ce sont des lésions nodulaires qui se ramoullissent puis se fistulisent au niveau de la peau.

Il y a aussi les tubercules. Donc les tubercules, c'est des lésions, donc c'est des surélévations à contenu solide comme des papules de diamètre moins important par rapport aux nodules et qui donnent des lésions cicatricielles. Elles donnent un infestement central avec une atrophie centrale.

Ces lésions sont regroupées sous forme arciforme, sous forme d'arc, ou sous forme cercinée, ou sous forme serpigneux, serpigneux, c'est-à-dire l'aspect des mouvements d'un serpent. Pour l'atteinte ostéoarticulaire, dans le cadre de la syphilis tertiaire, on peut voir des ostéochondrites des os longs, des osseïdes gommeuses des os plats, des osseïdes sclérose, des arthrites, des bursites, des synovites, des nodules fibreux juxta-articulaires. L'atteinte cardiaque peut survenir 20 ans après le choc.

Le tableau clinique le plus fréquent, c'est l'insuffisance aortique. Il peut y avoir également des lésions d'anévrisme calcifié de l'aorte et des lésions de coronarhites. La gravité de la syphilis tertiaire réside surtout dans l'atteinte neurologique.

Dans la neurosyphilis, il y a deux types d'atteintes. Il y a la neurosyphilis asymptomatique, on découvre une sérologie syphilitique positive dans le SR, alors que le malade ne présente pas de signes cliniques. Et la neurosyphilis symptomatique, soit sous forme de méningites ou de syphilis vasculaire cérébrale, d'atteinte vasculaire ou d'atteinte parenchymateuse, il y aura un cours plus détaillé sur la neurosyphilis dans la neurologie.

Le diagnostic de syphilis ne peut se faire que par la mise en évidence du tréponème lui-même au microscope à fond noir, ou indirectement par la mise en évidence de la réponse spécifique anticorps. L'examen au microscope à fond noir doit être pratiqué sur des lésions érosives, chancre de la syphilis primaire ou dans les syphilides érosifs au niveau du mycoses dans le cadre de la syphilis secondaire. La sensibilité au niveau du chancre est de 50%.

Il n'a aucune valeur au niveau buccal du fait de la possibilité du faux positif, puisqu'il existe des spirochettes saprophytes. Le diagnostic de la syphilis repose essentiellement sur la sérologie. Le microscope à fond noir n'est pas d'usage courant.

On demande deux types de réactions, la réaction VDRL et TPHA. VDRL, c'est une réaction non spécifique, puisqu'il utilise un antigène cardiolipidique. TPHA, c'est une réaction spécifique, puisqu'il utilise un antigène tréponémique.

C'est très important de connaître la cinétique de ces anticorps pour savoir interpréter la sérologie syphilitique. On va voir les différentes possibilités. Si on a comme réponse sérologique TPHA négative, VDRL négatif, soit que le malade ne présente pas de syphilis ou de tréponomatose,

parce qu'en général, il n'y a pas de sérologie qui différencie entre les tréponomatoses non vénériennes et la syphilis.

On a vu ça dans le cours sur les ulcérations génitales. On a dit qu'il y a des maladies tréponomatoses qui ne sont pas vénériennes, comme la maladie de Bégelle, la maladie de Pinta, et qui ont la même sérologie. Donc là, c'est un interrogatoire qu'il faut chercher l'origine du patient, parce que ce sont des maladies endémiques qui se vivent dans certains pays.

Donc, soit qu'on ait TPHA négatif VDRL, pas de tréponomatose, ou bien le malade a contacté la syphilis, mais elle est dans cette phase-là, donc avant même l'apparition du chancre syphilitique. Donc, il y a le contage, puis ces trois semaines après, il y a le chancre. Donc ici, la sérologie, elle est négative.

Ou bien la sérologie a été faite de façon précoce après le chancre, puisque la sérologie, TPHA et VDRL, ils ne sont positifs qu'à partir de, en général, aux alentours du huitième jour après le chancre. Il y a également une possibilité que le malade ait été diagnostiqué et traité précocement. À ce moment-là, on peut avoir une sérologie syphilitique négative.

Donc, si vous avez comme réponse sérologique VDRL positif et TPHA négatif, c'est un faux positif, puisque VDRL, il n'est pas spécifique et TPHA, il est spécifique. Si TPHA, il est négatif, donc ça élimine la syphilis. TPHA, il doit être positif pour parler de la syphilis.

Donc, TPHA négatif, c'est pas une syphilis. VDRL positif, c'est un faux positif. Ça peut se voir dans les maladies de système comme le lupus, le syndrome des anticorps antiphospholipides.

TPHA, VDRL positif, donc on est, là, il faut voir les valeurs de la VDRL. Donc, vous voyez les valeurs de la VDRL et voir également l'histoire clinique pour voir est-ce que c'est la syphilis primaire ou la syphilis secondaire. Donc, c'est une syphilis.

TPHA, donc TPHA positif, VDRL négatif. À ce moment-là, soit qu'on est dans une trépanémathose guérie, donc ça peut, TPHA reste positif et VDRL peut se négativer. Une syphilis qui a été traitée et guérie, donc ça, c'est l'interrogatoire, il faut chercher est-ce que le patient a été traité et donc ça peut persister, la TPHA persiste, VDRL peut se négativer.

Ça peut être la syphilis tertiaire. Vous voyez, si le malade n'a pas reçu de traitement, ça peut être la syphilis tertiaire. À ce moment-là, il faut faire un examen neurologique, autant le mycardiovasculaire, osteoarticulaire et cutané à la recherche des signes de la syphilis tertiaire s'il y a des signes neurologiques, donc des troubles de comportement, il faut faire une PL et une sérologie dans la syphilis, dans le liquide céphalo-rachidien, une sérologie du liquide céphalo-rachidien pour poser le diagnostic de neurosyphilis.

Donc, voilà les différentes situations pour l'interprétation de la sérologie syphilis. Donc, voilà, TPHA négatif, VDRL négatif, on a dit qu'il peut s'agir d'une absence de tréponématose, ou

syphilis en incubation, ou syphilis primaire, donc aux alentours du huitième jour avant l'apparition des anticorps, ou syphilis guéri traité précocement. TPHA négatif, VDRL positif, c'est un faux positif, donc ça se voit dans les maladies du système, le syndrome des anticorps antiphospholipides, TPHA positif, VDRL négatif, les séquelles sérologiques d'une tréponneumatose, syphilis a priori guéri, TPHA positif, VDRL positif, c'est une syphilis en tréponneumatose évolutive, et il faut voir le taux des anticorps et, tant que l'examen clinique, l'interrogatoire pour voir est-ce que c'est une syphilis primaire ou secondaire.

Pour le diagnostic différentiel, au stade de syphilis primaire, donc au stade de chancre, le diagnostic différentiel est celui des autres causes d'ulcérations génitales. Il faut systématiquement évoquer la syphilis devant toute ulcération muqueuse, donc les ulcérations génitales, anales ou mycopharyngées, et bien sûr, il faut donc éliminer les autres diagnostics différentiels qu'on a vus dans le cours sur les ulcérations génitales, les lésions de chancre mou, l'herpès, la donovanose, la maladie de Nicolas Favre. Pour la syphilis secondaire, donc la syphilis secondaire est la grande simulatrice et il doit être évoqué devant toute éruption maculopapuleuse, fugace ou persistente.

Au stade de la roséole, le diagnostic différentiel c'est les autres virus qui donnent également un exantème viral ou une toxidémie médicamenteuse. À l'interrogatoire, il faut chercher la notion de prise médicamenteuse. Donc, les syphilides, rappelez-vous que la lésion alimentaire c'est des papules, et ces papules peuvent être recouvertes de squames, et ça peut poser donc le diagnostic différentiel avec un psoriasis ou un lichen blanc.

Également, ces lésions, donc ces papules rouges cuivrées, peuvent également poser le diagnostic de sarcoïdose ou des hématochromes. Donc pour le traitement, la syphilis précoce que regroupe la syphilis primaire, la syphilis latente, la secondaire et la syphilis latente précoce se traitent de la même manière. Donc c'est la benzathine, pénicilline G, 2,4 millions en injection intramusculaire.

Si le patient est allergique à la pénicilline, on donne des cyclines, donc la doxycycline à raison de 200 mg par jour pendant 15 jours, ou tetracycline 2 g par jour pendant 15 jours. Si le patient est allergique à la pénicilline et il y a une contre-indication aux cyclines, s'il a fait une toxidermie par exemple également aux cyclines, forme grave de toxidermie, à ce moment-là, ce qui est recommandé, c'est de faire une désensibilisation à la pénicilline. Donc en général, c'est des malades qu'il faut hospitaliser à côté d'un service de réanimation de soins intensifs et faire donc des schémas de désensibilisation.

On donne de la pénicilline à des doses progressives, des doses croissantes sous couverture de traitement par des corticoïdes et d'antihistaminiques, il y a le risque de choc anaphylactique, donc on fait cette désensibilisation dans un milieu hospitalier. Le traitement de la syphilis tardive à l'exclusion de la neurosyphilis qui a un schéma thérapeutique propre que vous allez voir dans le cours de la neurosyphilis en neurologie. Donc le malade pour la syphilis tardive, donc ces trois



injections intramusculaires de benzatine, pénicilline à raison de 2,4 millions d'unités à une semaine d'intervalle.

Si le patient est allergique à la pénicilline, il faut faire une pension lombaire pour éliminer une neurosyphilis. Donc il faut faire une sérologie syphilitique dans le LCR. Si la sérologie est négative, on donne un traitement par les cyclines, donc soit la doxycycline à raison de 200 mg par jour pendant quatre semaines ou la tétracycline de 2 g par jour pendant quatre semaines.

Si la sérologie syphilitique dans le LCR est positive, à ce moment-là, il faut faire une désensibilisation à la pénicilline et traiter comme neurosyphilis. Pour le traitement de la syphilis chez la femme enceinte, donc le risque chez la femme enceinte, c'est celui de la syphilis congénitale. On n'a pas parlé de la syphilis congénitale parce qu'il y aura un cours de pédiatrie sur la syphilis congénitale que vous allez voir dans le cours de pédiatrie.

Donc classiquement, le tréponème ne passe la barrière placentaire qu'à partir du quatrième, cinquième mois de la grossesse et dans le suivi régulier des grossesses, il faut toujours demander une sérologie syphilitique. Donc le traitement de la syphilis chez la femme enceinte est identique pour un même stade de la maladie à celui préconisé chez la femme enceinte. Donc si c'est une syphilis préconisée, une injection.

Si c'est une syphilis tardive, c'est trois injections intramusculaires de benzalcine, pénicilline. L'efficacité du traitement doit être contrôlée cliniquement et biologiquement. Dans le cadre de la syphilis primaire et la syphilis secondaire, les lésions régressent en général sept jours, huit jours.

Donc il y a disparition de l'ulcération dans le cadre de la syphilis primaire et des lésions cutanées dans le cadre de la syphilis secondaire. Il peut y avoir des séquelles leucomélanodermiques dans la syphilis secondaire. Des séquelles leucomélanodermiques, ça veut dire que le malade peut garder des macules pigmentées ou des macules achromiques.

Et lorsque ces lésions se sont localisées, ces lésions sont localisées au niveau du décolleté, on parle du collier de l'ulcération. Donc on peut avoir des lésions qui sont localisées au niveau du décolleté. Pour l'évolution biologique, la surveillance doit être faite par la réaction VDRL quantitatif.

Ça ne sert à rien de demander VDRL qualitatif ou de vous demander TPHA. VDRL TPHA pour confirmer le diagnostic, on demande VDRL quantitatif, TPHA qualitatif. Pour le suivi, on demande VDRL quantitative.

Les titres doivent diminuer d'un facteur 4 au sixième mois. Donc il faut qu'il y a deux dilutions, c'est à dire si vous avez par exemple un taux d'anticorps 1 sur 32, au sixième mois, 32 doit être divisé par 4, ça va donner donc 1 sur 8. Si vous avez 1 sur 8, c'est une bonne évolution. Et après on demande une sérologie à un an et puis à deux ans.

En général, le VDRL doit être négatif un an après le traitement du syphilis primaire et dans un délai de deux ans après le traitement du syphilis secondaire. Parfois il peut persister un faible taux d'anticorps, donc 1 sur 2, on parle de cicatrices sérologiques. En guise de conclusion, la syphilis est une infection sexuellement transmissible dite au *tréponema pallidum* qui évolue en trois phases.

La phase primaire avec le chancre syphilitique, la phase syphilis secondaire qui se caractérise par un grand polymorphisme clinique. Si on ne traite pas les malades au stade de chancre syphilitique, au stade de la syphilis secondaire, il y a un grand risque de passer à la phase tertiaire avec le risque majeur de neurosyphilis qui fait la gravité de la maladie. La syphilis est une maladie sexuellement transmissible, donc il faut toujours chercher les autres pathologies sexuellement transmissibles qui peuvent s'associer, donc il faut demander à la sérologie VIH après consentement du patient, chercher l'hépatite B et C, chercher s'il y a d'autres maladies sexuellement transmissibles, les végétations vénériennes, les urétrites.

Donc le traitement est bien codifié et il faut insister bien sûr sur l'éducation, l'information, la sensibilisation pour prévenir ces maladies sexuellement transmissibles.